

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091722-21.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: JOAO LUKAS DOS SANTOS RODRIGUES PACHECO

RECORRIDO: DAYANE DOS SANTOS ALVES

MEDIDA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SAUDE. CANABIDIOL. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS INSUFICIENTES. MANIFESTAÇÃO DO NAT PELA NECESSIDADE DE ESTUDOS. IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO FORNECER MEDICAMENTO OU PRODUTOS EXPERIMENTAIS. TEMA 500 DO STF. RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da União. Publique-se. Intimadas as partes, certifique-se o trânsito em julgado, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2025.

5091722-21.2024.4.02.5101

510015141865 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091722-21.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: JOAO LUKAS DOS SANTOS RODRIGUES PACHECO

RECORRIDO: DAYANE DOS SANTOS ALVES

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União em face da decisão, *verbis* (processo nº 5074426-83.2024.4.02.5101, evento 35, DESPADEC1).

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação movida por JOÃO LUKAS DOS SANTOS RODRIGUES PACHECO, representado por DAYANE DOS SANTOS ALVES, em face da UNIÃO FEDERAL, do ESTADO DO RIO DE JANEIRO e do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, na qual pretende, em sede de tutela de urgência, o fornecimento de CANABIDIOL E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, nas doses, quantidade e prazos prescritos por médico assistente.

Segundo o relatado na petição inicial, o autor, criança de 6 anos, acompanhado pelo Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira, em razão de diagnóstico de Doença Genética Congênita rara NEDIM (Neurodevelopmental Disorder With Involuntary Movements (CID 10: G31, F98, R25) possui condições especiais de saúde no desenvolvimento psicomotor de início infantil de movimentos involuntários hiperkinéticos, incluindo coreia e atetose.

No início de 2024, apresentou quadro febril com pneumonia e foi internado para tratamento clínico, abrindo então quadro de movimentos distônicos com rápida evolução para gravidade, com necessidade de suporte intensivo ventilatório e hemodinâmico, nos três meses que permaneceu em unidade de terapia intensiva, foram tentadas várias estratégias medicamentosas para controle dos movimentos sem êxito completo, com melhor resposta com uso de Canabidiol, devido a este quadro o autor foi submetido a gastrostomia e traqueostomia para melhor qualidade de vida, possibilitando a alimentação e permeabilidade das vias aéreas.

Nesse sentido, a médica assistente prescreve o produto Canabidiol (Prati-Donaduzzi®) 200mg/ml suspensão oral e o insumo Fórmula tipo suplemento alimentar em pó (Pediasure, Fortini, Nutren Jr ou similar) 8,8kg mensais.

Decido.

Nos termos do art. 196 da Constituição da República (CRFB/1988), a saúde é direito de todos e dever do Estado, representando, assim, uma garantia constitucional para o indivíduo.

Vale destacar que o art. 198 da CRFB/1988, ao dispor sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelece que este será financiado pela União, Estados-membros e Municípios, do que decorre a responsabilidade solidária dos referidos entes públicos no caso posto nos presentes autos.

Seguindo este mesmo entendimento, já consolidado no âmbito jurisprudencial, no sentido de que ao Estado (gênero) incumbiria a responsabilidade de proporcionar os meios para se garantir a saúde dos cidadãos, inclusive com o fornecimento de medicamentos, foi editado o Enunciado nº 43 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, estabelecendo que “a União é parte legítima nas demandas que visem assegurar o direito às prestações do Sistema Único de Saúde - SUS”.

Como forma de garantia e preservação da saúde, encontra-se incluído no campo de atuação do SUS o fornecimento de medicamentos, nos termos do inciso, I, alínea d, do art. 6º da Lei nº 8.080/1990, devendo ser assegurado a pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação de que necessitem.

Em observância ao princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde, destaca-se, nos termos da jurisprudência dominante, que a garantia aos medicamentos deve se dar mesmo que estes não constem na listagem oficial, de vez que o não preenchimento de mera formalidade - no caso, a inclusão de medicamento em lista prévia - não pode, por si só, obstaculizar o fornecimento gratuito de medicação, se comprovada a respectiva necessidade e receitada, aquela, por médico para tanto capacitado (RESP - RECURSO ESPECIAL - 684646/RS).

Cumprе salientar que, em maio de 2019, no julgamento do RE 657.718/MG, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental ou sem registro na ANVISA, salvo em casos excepcionais.

Por maioria, o Pleno do STF fixou a seguinte tese:

1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”.

Contudo, em julgamento no plenário virtual do STF, nos autos do RE nº 1165959, em que se discutia a obrigatoriedade de fornecimento de Canabidiol em paciente com epilepsia de difícil controle, a Corte Constitucional decidiu que, embora não haja registro do medicamento no Brasil, sendo caso de importação excepcional para uso próprio, individualizado, ao Estado cumpre viabilizar a aquisição. Ao final, foi fixada a seguinte tese:

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Assim, de acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 1165959, é possível o fornecimento pelo Estado, de forma excepcional, de medicamento sem registro na ANVISA, desde que a sua importação tenha sido autorizada pela agência de vigilância sanitária, bem como sejam comprovadas (i) a incapacidade econômica do paciente, (ii) a imprescindibilidade clínica do tratamento e (iii) a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Sobre o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, devem estar preenchidos os requisitos que foram estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo com repercussão geral reconhecida no REsp nº 1.657.156/RJ, nos termos da ementa colacionada a seguir:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glauca 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico

em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

Então, nos termos da recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.657.156/RJ, para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde, a parte deve comprovar: i) a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, com 6 anos de idade, é portadora de Doença Genética Congênita rara NEDIM (Neurodevelopmental Disorder With Involuntary Movements (CID 10: G31, F98, R25), consoante laudo médico acostado em Evento 1, OFIC2, Pg.16/22.

Nos documentos acostados em Evento 1, OFIC2, Pg.18, verifica-se que o autor já fez uso de Topiramato e Clobazan, medicamentos presentes na lista de fornecimento do SUS, conforme indicado pelo parecer do NATJUS (Evento 33).

As informações prestadas pelo parecer técnico do NAT-Jus esclarecem que:

(...)

Os dados revisados apontam para um papel protetor do canabidiol (CBD) no tratamento e/ou prevenção de alguns distúrbios do movimento. Embora os estudos sejam escassos, o CBD parece ser eficaz no tratamento de movimentos distônicos, tanto primários quanto secundários. Investigações futuras são necessárias para endossar esses dados iniciais e elucidar os mecanismos envolvidos no potencial preventivo e/ou terapêutico do CBD em distúrbios do movimento¹.

Considerando todo o exposto acima, conclui-se que são escassas as evidências científicas que apoiam o uso de produtos derivados de Cannabis para o manejo do quadro clínico do Autor - doença genética congênita rara NEDIM (Neurodevelopmental Disorder With Involuntary Movements).

De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Epilepsia, o objetivo do tratamento da epilepsia é propiciar a melhor qualidade de vida possível para o paciente, pelo alcance de um adequado controle de crises, com um mínimo de efeitos adversos, buscando, idealmente, uma remissão total das crises. Os fármacos antiepilépticos são a base do tratamento da epilepsia. Os tratamentos não medicamentosos são viáveis apenas em casos selecionados, e são indicados após a falha dos antiepilépticos².

No que diz respeito ao tratamento das epilepsias refratárias, os últimos anos têm mostrado um aumento significativo de estudos que avaliam os riscos e benefícios do uso de canabinóides para a referida condição³.

No entanto, os cinco principais estudos que levaram à aprovação do **Canabidiol** no tratamento adjuvante na epilepsia apontam sua eficácia somente em pacientes com síndromes de Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. A eficácia do **Canabidiol** em outras epilepsias fármacorresistentes ainda não está bem estudada. Salienta-se que o quadro epilético apresentado pelo Autor, não possui origem nas condições supraditas - síndromes de Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa.

(...)

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) avaliou o **Canabidiol** no tratamento de crianças e adolescentes com epilepsia refratária a medicamentos antiepilépticos, e recomendou a sua não incorporação pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

(...)

Quanto à indicação do pleito, destaca-se que até o momento não há registrado no Brasil medicamento de princípio ativo **Canabidiol** com indicação para o tratamento da epilepsia.

O uso compassivo do **Canabidiol** como terapêutica médica foi regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, através da Resolução CFM nº 2.113, de 16 de dezembro de 2014, devendo este ser **destinado exclusivamente para o tratamento de epilepsias na infância e adolescência refratárias às terapias convencionais e associado aos medicamentos que o paciente vinha utilizando anteriormente.**

No que tange à disponibilização, no âmbito do SUS, cabe informar que o canabidiol 100mg/mL (Prati-Donaduzzi®) não integra nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) dispensados no Município e do Estado do Rio de Janeiro. Logo, não cabe o fornecimento em nenhuma esfera do SUS.

(...)

No que tange ao suplemento nutricional pleiteado, cumpre participar que problemas de alimentação são comuns em crianças com paralisia cerebral (PC) levando a estado de má nutrição e falha no crescimento, principalmente nas formas mais graves de PC, em que ocorre aumento do tônus muscular e reflexos tendinosos profundos nas quatro extremidades do corpo¹¹ . Salienta-se que quanto maior o grau de comprometimento motor, maiores as dificuldades de alimentação¹² .

Nesse contexto, de acordo com a Diretriz Brasileira de Terapia Nutricional Domiciliar, em pacientes em terapia nutricional domiciliar com gastrostomia, como no caso do autor, é recomendado que seja ofertada dieta mista, onde é intercalada a oferta de dieta artesanal com dieta industrializada ou módulos industrializados, ou dieta industrializada, mediante o quadro de distúrbio metabólico, desnutrição, lesão por pressão, ou más condições higiênico-sanitárias¹³ . Nesse contexto, fica a cargo do profissional assistente indicar a dieta mais adequada para o caso do autor.

Quanto ao estado nutricional do autor, foi informado o dado antropométrico peso: 17kg (Evento 1, ANEXO2, Página 21), foi avaliado segundo o gráfico de crescimento específico para crianças com paralisia cerebral com nível GMFCS V, alimentação via gastrostomia, citado na Diretriz de Atenção à Pessoa com Paralisia Cerebral do Ministério da Saúde¹⁴. Nesse contexto, foi observado que o autor apresenta peso/idade entre o percentil 25 e 50, indicando peso adequado para a idade¹⁵ .

Por fim, esclareceu o NAT-Jus que:

“De acordo com o documento médico acostado (Evento 1, ANEXO2, Página 28 a 31), “o autor se alimenta por meio de gastrostomia e atualmente o calibre da sonda é 14FR, não possibilita a utilização de dieta artesanal com as calorias adequadas para a manutenção da nutrição adequada ao autor” Sendo assim, diante do exposto, as opções prescritas são viáveis para o uso do autor, para a manutenção do seu estado nutricional. Acerca da quantidade prescrita 36,5g, 7 vezes ao dia totalizando 255,5 e 8,8kg por mês, proporcionariam ao autor um aporte calórico e proteico diário de:

- Pediasure® Complete - 999 kcal e 36g, para o atendimento da quantidade prescrita seriam necessárias 22 latas de 400g ou 11 latas de 850g;

- Fortini®Plus - 1.116 kcal e 24,8g, para o atendimento da quantidade prescrita seriam necessárias 22 latas de 400g;

- Nutren® Junior - 1.190 kcal e 36g, para o atendimento da quantidade prescrita seriam necessárias 22 latas de 400g.

Ressalta-se que indivíduos em uso de fórmulas nutricionais industrializadas necessitam de reavaliações periódicas, visando verificar a evolução do quadro clínico e a necessidade da permanência ou alteração da terapia nutricional inicialmente proposta. Nesse contexto, em documento médico/nutricional acostado foi informado que “o paciente necessita de dieta industrializada via GTT, como suplementação, para atingir suas necessidades nutricionais por no mínimo 6 meses, até a troca da sonda para maior calibre e início de dieta artesanal”.

(...)

A propósito, em 22/04/2020, a ANVISA emitiu autorização sanitária do primeiro produto à base de Cannabis para ser comercializado no país, classificando-o como fitoterápico/produto e não como medicamento:

Com a autorização concedida, a empresa pode iniciar a fabricação e a comercialização do produto. Conforme a autorização, o canabidiol poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro.

indicação e a forma de uso dos produtos à base de Cannabis são de responsabilidade do médico assistente, sendo que os pacientes devem ser informados sobre o uso dos produtos em questão. As informações fornecidas devem contemplar: os riscos à saúde envolvidos; a condição regulatória do produto quanto à comprovação de segurança e eficácia, informando que o produto de Cannabis não é medicamento; os possíveis efeitos adversos, tomando como exemplo, mas não se restringindo a isso, a sedação e o comprometimento cognitivo, que podem impactar no trabalho, no ato de dirigir e operar máquinas ou em outras atividades que impliquem riscos para si ou terceiros; e os cuidados na utilização. Além disso, o paciente ou, na sua impossibilidade, o seu representante legal deve assinar Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) sobre a utilização do produto de Cannabis.

(Fonte: http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/anvisa-autoriza-primeiro-produto-base-de-cannabis/219201?p_auth=QqssILSs&inheritRedirect=false).

Verifica-se, portanto, que foi autorizada a prescrição do Canabidiol quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro, cabendo ao médico assistente, a indicação e a forma de uso.

Na hipótese dos autos, o médico assistente do autor indicou o uso do medicamento à base de Canabidiol.

Nesse contexto, evidencia-se a imprescindibilidade da utilização do canabidiol para o manejo do quadro clínico do autor, visto que ele faz uso das opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, mas não se conseguiu obter o controle satisfatório da patologia sem a inclusão conjunta do medicamento ora pleiteado, o que, inclusive, pode levar a quadro de óbito.

A jurisprudência, por sua vez, vem reconhecendo o direito de pacientes ao fornecimento de medicamentos derivados de Canabidiol:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. MENOR PORTADORA DE SÍNDROME DE GANER E DE TRANSTORNO DE HUMOR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL E LURASIDONA.

Sentença que julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento do fármaco à base de Canabidiol, além do medicamento Lurasidona. Irresignação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.

1. Preliminares de incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva ad causam afastadas. Litisconsórcio passivo entre entes federativos que é facultativo. Inaplicabilidade, no caso concreto, do Tema nº 500 do E. STF. Fármacos à base de Canabidiol que apresentam situação regular, enquadrando-se em categoria regulatória própria, conforme esclarecimentos prestados pela Anvisa.

2. Cerceamento de defesa não configurado. Prova documental que se mostra suficiente para comprovar a necessidade da autora.

3. Direito à saúde assegurado pelo art. 6º da CF, artigos 11 e 4 do ECA, bem como artigo 2º da Lei nº 8.080/90, que abrange a obtenção gratuita de insumos e medicamentos necessários ao tratamento do enfermo.

4. Fármaco à base de Canabidiol que, embora não possua registro na ANVISA, teve sua produção e comercialização recentemente disciplinadas por essa agência reguladora. Esgotamento das alternativas convencionais suficientemente comprovado.

5. Processo sujeito à Tese Vinculante firmada no julgamento do Tema nº 106 do E. STJ no que diz respeito ao medicamento prescrito, cujos requisitos foram preenchidos. Necessidade comprovada por meio de prescrição subscrita pelo médico que acompanha o tratamento da adolescente. Ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e hipossuficiência para arcar com o custo dos fármacos prescrito demonstradas.

6. Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos.

(TJ-SP - AC: 10010098320218260344 SP 1001009-83.2021.8.26.0344, Relator: Daniela Cilento Morsello, Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmara Especial, Data de Publicação: 17/08/2021). (Destacamos.).

MEDICAMENTO. HEMPFLEX 6000 - (CANABIDIOL). CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

A análise sumária, possível para o estágio em que se encontra o processo principal, permite ilação no sentido da existência dos requisitos para a concessão da tutela pretendida. In casu, o agravado apresenta quadro de Transtorno do Espectro Autista, com provável déficit cognitivo associado. E, de acordo com o médico que o acompanha, não houve resposta aos medicamentos neurolépticos ou antidepressivos, tendo ocorrido, inclusive, piora clínica. Logo, não se contesta a presença do periculum in mora, visto que a medicação indicada pelo profissional é necessária para a manutenção e melhora do quadro de saúde do recorrido. Além disso, há norma específica referente à possibilidade de importação de medicamentos à base de Canabidiol, qual seja, a RDC nº 17/2015, da ANVISA. Além disso, no dia 11/12/2019, foi publicada no D.O. da União, a RDC nº 327/2019, também da ANVISA, que dispõe sobre os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária referente aos produtos de Cannabis para fins medicinais. Exceções normativas que afastam a incidência do REsp 1.712.163/SP (tema 990), encontrando-se presente a probabilidade do direito. Valor da multa devidamente arbitrado, não se revelando excessivo e fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade. De fato, tratando de

medicamento que precisa ser importado, o prazo de 05 dias é por demais curto, impondo-se a dilação para 15 dias úteis. Conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo de instrumento.

(TJ-RJ - AI: 00859585120208190000, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 26/05/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021). (Destacamos).

No que se refere à incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, impõe-se ressaltar que a representante legal do autor se encontra desempregada (evento 1, ANEXO2, págs. 9/11), razão pela qual se presume a sua hipossuficiência financeira e a impossibilidade de arcar com o custo do tratamento.

Em virtude da hipossuficiência da representante da parte autora, que comprova a situação de desempregada, também vislumbro a dificuldade em adquirir os produtos necessários para manutenção alimentar do seu filho. Nesse sentido, conforme indicação médica conjuntamente com o parecer do NATJUS, entendo razoável a concessão do suplemento nutricional na quantidade de 264 latas para 12 meses.

Ante todo o exposto, então, resta inconteste a necessidade e a urgência de administração do medicamento e do suplemento alimentar pleiteado pelo autor, visto que comprovada a prescrição pela médica que o assiste para o quadro clínico do paciente.

Dessa forma, é manifesta a prova inequívoca do direito, bem como a plausibilidade da alegação autoral, por ser dever do Estado garantir às pessoas o direito relativo à saúde, mediante acesso universal e igualitário aos procedimentos médicos e medicamentos indispensáveis para o tratamento de doenças graves, de onde deflui o fumus boni iuris.

Do mesmo modo, é incontroverso o periculum in mora, à vista dos documentos médicos juntados aos autos pela autora, bem como das informações constantes do parecer apresentado pelo NAT, onde foi ressaltado o risco de agravamento do estado de saúde do paciente.

Diante do exposto, **DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA** e determino que os réus, de forma solidária, forneçam à parte autora o medicamento Canabidiol 100mg/ml (suspensão oral) e suplemento nutricional, conforme prescrito pelo médico assistente, em quantidade necessária inicialmente para seis meses, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa cominatória a ser arbitrada pelo Juízo, em caso de descumprimento, devendo os réus, no mesmo prazo, comunicar ao Juízo o cumprimento da tutela ora deferida.

Considerando a necessidade de direcionamento do encargo financeiro em razão do sistema de repartição de competências, nos termos da tese 793 do STF, direciono o cumprimento à União Federal, inicialmente, considerando que os insumos não fazem parte de nenhuma lista de dispensação do SUS, no âmbito do Município e do Estado do Rio de Janeiro.

O medicamento e os insumos deverão ser disponibilizados à parte autora, ficando a entrega para os semestres seguintes, condicionada à apresentação de receituário médico atualizado.

Na hipótese de bloqueio das verbas através do SISBAJUD, a parte autora deverá juntar nos autos, no prazo de 20 dias, cópias (legíveis e não repetidas) das notas fiscais comprovando a aquisição dos insumos, sob pena de remessa de peças ao Ministério Público para adoção das providências cabíveis

A prescrição médica deverá observar o Enunciado nº 15 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, in verbis:

As prescrições médicas devem consignar o tratamento necessário ou o medicamento indicado, contendo a sua Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional - DCI, o seu princípio ativo, seguido, quando pertinente, do nome de referência da substância, posologia, modo de administração e período de tempo do tratamento e, em caso de prescrição diversa daquela expressamente informada por seu fabricante a justificativa técnica.

A se considerar que o medicamento pleiteado pelo autor não consta de lista de dispensação pelo SUS, intime-se a parte autora, por meio de remessa dos autos à DPU, para que, no prazo de 10 (dez) dias, junte aos autos três orçamentos do medicamento.

Deve a parte autora, ainda, efetuar o seu cadastro na Coordenaria do Município de Atendimento de Mandado (Estrada dos Bandeirantes, nº 1700, Lote 02 - Galpão 01 - Armazéns 109 a 119, Taquara, Jacarepaguá - Rio de Janeiro/RJ), bem como na Central de Atendimento a Demandas Judicial do Estado (Rua México, nº 128 - Centro - Rio de Janeiro/RJ).

Fique ciente a parte autora de que deverá manter contato permanente com as Centrais através dos telefones 3432-4489, 3432-4863 ou 3432-4591 (Central do Município) e 23320988 ou 23320956 (Central do Estado).

Determino a intimação dos réus, através do e-Proc, no modo URGENTE, para efetivo cumprimento desta decisão, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme acima determinado, devendo os representantes dos Entes Públicos fazer contato diretamente com o paciente, nos telefones de contato constantes nos autos (petição inicial).

Citem-se as partes rés para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentem contestação, nos do art. 9º da Lei nº 10.259/2001, e do parágrafo 4º do art. 11 do Provimento nº 02/2002 da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região. Na oportunidade, deverão ainda

apresentar toda a documentação de que disponham para o esclarecimento da lide, tudo nos termos do caput do art. 11 da Lei nº 10.259/2001, bem como verificar se há prevenção, conforme dispõe o art. 337, VI, VII e VIII, do CPC.

Intimem-se as partes, bem como o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF."

A União interpôs medida de urgência no evento 1, REC1.

A parte autora apresentou agravo interno no evento 16, AGR_INTERNO1.

Essa relatoria determinou o retorno dos autos ao NAT.

O NAT juntou parecer no evento 39, PARECER1.

É o breve relatório.

VOTO

No caso dos autos, foi proferida a decisão do evento 3, DOC1.

Foi realizada, corretamente, a intimação do Núcleo de Assistência Técnica, NAT, para emissão de parecer, nos termos do que dispõe o Enunciado 13 do CNJ: "*Nas ações de saúde que pleiteiam o fornecimento de medicamentos, produtos ou tratamentos, recomenda-se, sempre que possível, a prévia oitiva do gestor do Sistema Único de Saúde - SUS, com vistas a, inclusive, identificar solicitação prévia do requerente, alternativas terapêuticas e competência do ente federado, quando aplicável (Saúde Pública e Suplementar). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)*"

O parecer do Nat foi juntado no evento 33, (processo nº 5074426-83.2024.4.02.5101, evento 33, PARECER1):

PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS-FEDERAL Nº 1873/2024

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

Processo nº 5074426-83.2024.4.02.5101,
ajuizado por **João Lukas dos Santos Rodrigues Pacheco**, representado por **Dayane dos Santos Alves**.

O Autor, 06 anos (DN: 31/05/2018), apresenta diagnóstico de doença genética congênita rara **NEDIM (Neurodevelopmental Disorder With Involuntary Movements)**, com agressividade, agitação psicomotora e atraso grave do desenvolvimento neuromotor secundários ao quadro de base, e por consequência possui condições especiais de saúde no desenvolvimento psicomotor de início infantil de movimentos involuntários hipercinéticos, incluindo coreia e atetose, e, no início de 2024, apresentou quadro febril com pneumonia e foi internado para tratamento clínico, abrindo então quadro de movimentos distônicos com rápida evolução para gravidade, com necessidade de suporte intensivo ventilatório e hemodinâmico, nos três meses que permaneceu em unidade de terapia intensiva, foram tentadas várias estratégias medicamentosas para controle dos movimentos sem êxito completo, com melhor resposta com uso de **Canabidiol**, devido a este quadro o autor foi submetido a gastrostomia e traqueostomia para melhor qualidade de vida, possibilitando a alimentação e permeabilidade das vias aéreas.

Atualmente o calibre da sonda de gastrostomia é 14FR, e não possibilita a utilização de dieta artesanal com calorias adequadas para manutenção da nutrição adequada para o requerente, de maneira que é fundamental o fornecimento de fórmula nutricional para a alimentação. Apresenta risco nutricional (magreza acentuada, peso de 17kg, entre percentil -2 e -1).

Apresenta quadro de **epilepsia de difícil controle** (CID-10: G40.0) em uso de clobazam, topiramato, haloperidol, risperidona, triexifenidil (Artane®) e baclofeno.

Sendo solicitado o produto **canabidiol 100mg/mL** (Prati-Donaduzzi®) 26 gotas de 12 em 12 horas e fórmula tipo **suplemento alimentar em pó** (Pediasure, Fortini, Nutren Jr ou similar) – 8,8 kg ao mês, ou seja, 36,5 gramas de pó diluídos em 180ml de água, 7 vezes ao dia, pela gastrostomia (Evento 1, ANEXO2, Páginas 16-27).

Os dados revisados apontam para um papel protetor do canabidiol (CBD) no tratamento e/ou prevenção de alguns distúrbios do movimento. Embora os estudos sejam escassos, o CBD parece ser eficaz no tratamento de movimentos distônicos, tanto primários quanto secundários. Investigações futuras são necessárias para endossar esses dados iniciais e elucidar os mecanismos envolvidos no potencial preventivo e/ou terapêutico do CBD em distúrbios do movimento¹.

Considerando todo o exposto acima, **conclui-se que são escassas as evidências científicas que apoiam o uso de produtos derivados de Cannabis para o manejo do quadro clínico do Autor** - doença genética congênita rara NEDIM (Neurodevelopmental Disorder With Involuntary Movements).

No entanto, os cinco principais estudos que levaram à aprovação do **Canabidiol** no tratamento adjuvante na **epilepsia** apontam sua eficácia **somente** em pacientes com síndromes de Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. A eficácia do **Canabidiol** em **outras epilepsias farmacorresistentes** ainda não está bem estudada⁴. Salienta-se que o quadro epilético apresentado pelo Autor, **não possui origem** nas supraditas condições – síndromes de Dravet, Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa.

O parecer técnico-científico, elaborado em dezembro de 2023 pelo Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde – Hospital Sírio Libanês (NATS-HSL) avaliou o **Canabidiol** no manejo da epilepsia e concluiu com base em evidências de certeza muito baixa a moderada que, quando comparado ao placebo, o **Canabidiol** provavelmente apresenta maior redução das crises convulsivas em indivíduos com epilepsia refratária. Quanto à segurança, a maioria das doses e formas de esquemas de tratamento analisados parecem aumentar a incidência de eventos adversos graves e de quaisquer eventos adversos. Com relação à qualidade de vida, o **Canabidiol** pode apresentar pouca ou nenhuma diferença comparada ao placebo⁵.

A **Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC)** avaliou o **Canabidiol** no tratamento de **crianças e adolescentes** com epilepsia refratária a medicamentos antiepiléticos, e recomendou a sua **não incorporação** pelo Sistema Único de Saúde – SUS⁶.

A CONITEC considerou não haver evidências suficientes para justificar a incorporação de um produto de *Cannabis* específico. Dentre os motivos, constam: grande variabilidade de apresentação dos produtos de *Cannabis*; não comprovação de intercambialidade ou equivalência entre os produtos disponíveis e os que foram utilizados nos estudos clínicos; incertezas quanto à eficácia e magnitude do efeito dos produtos de *Cannabis* para a indicação proposta⁸.

Quanto à indicação do pleito, destaca-se que até o momento não há registrado no Brasil **medicamento** **Canabidiol** com indicação para o tratamento da **epilepsia**.

O uso compassivo do **Canabidiol** como terapêutica médica foi regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, através da Resolução CFM nº 2.113, de 16 de dezembro de 2014, devendo este ser destinado **exclusivamente** para o tratamento de epilepsias na infância e adolescência

No que tange à disponibilização, no âmbito do SUS, cabe informar que o **canabidiol 100mg/mL** (Prati-Donaduzzi[®]) **não integra** nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) dispensados no Município e do Estado do Rio de Janeiro. Logo, não cabe o fornecimento em nenhuma esfera do SUS.

Para o tratamento da epilepsia, o Ministério da Saúde publicou a Portaria Conjunta SCTIE/SAS/MS nº 17, de 21 de junho de 2018, a qual dispõe sobre o **Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da epilepsia**⁵. Em conformidade com o PCDT⁵ são **padronizados** os seguintes medicamentos:

- Por meio do **CEAF** (Componente Especializado da Assistência Farmacêutica), a Secretaria de Estado de Saúde de Rio de Janeiro (SES/RJ) **atualmente** disponibiliza os seguintes medicamentos: Gabapentina 300mg e 400mg (cápsula); Vigabatrina 500mg (comprimido); Lamotrigina 100mg (comprimido), Topiramato 25mg, 50mg e 100mg (comprimido) e Levetiracetam 250mg, 500mg, 750mg, 1000mg e 100mg/mL;
- No âmbito da Atenção Básica Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, disponibiliza-se os seguintes medicamentos: Ácido Valpróico 250mg, 500mg (comprimido) e 250mg/5mL (xarope), Carbamazepina 200mg (comprimido) e 20mg/mL (xarope), Clonazepam 0,5mg, 2mg (comprimido) e 2,5mg/mL (solução oral), Fenitoína 100mg (comprimido), Fenobarbital 100mg (comprimido) e 40mg/mL (solução oral).

Em consulta realizada ao Sistema Nacional de Gestão de Assistência Farmacêutica (HÓRUS) verificou-se que o Autor **não está cadastrado** no CEAF para a retirada dos medicamentos padronizados.

Cabe esclarecer que em documento médico acostado aos autos foi mencionado que o Autor faz uso de “...*clobazam e topiramato*” (Num. 140606651 - Pág. 1). Assim, destaca-se que a Autora está em uso de **alguns dos medicamentos preconizados no PCDT e disponibilizados no âmbito do SUS para o manejo da Epilepsia, ou seja, já estão sendo empregados no plano terapêutico do Autor**.

Insta mencionar que especificamente o produto **canabidiol 100mg/mL** (Prati-Donaduzzi[®]) **possui registro** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Tal produto encontra-se registrado como **produto de cannabis e não como medicamento**.

Conforme a RDC Nº 327, de 9 de dezembro de 2019, o **Canabidiol** poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro. A indicação e a forma de uso dos produtos à base de *Cannabis* são de responsabilidade do médico assistente⁸.

O parecer do NAT afirmou que o medicamento/produto não foi incorporado ao SUS e que não há evidências científicas robustas que embasem o uso de produtos derivados de Cannabis para o manejo da epilepsia, uma das patologias que acometem a parte autora.

O NAT foi intimado para se manifestar novamente quanto ao uso de Cannabis para o manejo do quadro clínico da doença congênita rara NEDIM e juntou novo parecer no (evento 39, PARECER1).

Rio de Janeiro, 09 de dezembro de 2024.

Processo nº 5091722-21.2024.4.02.5101,
ajuizado por **João Lukas dos Santos
Rodrigues Pacheco**, representado por
Dayane dos Santos Alves.

O Autor, apresenta diagnóstico de **NEDIM (Neurodevelopmental Disorder With Involuntary Movements)**, doença genética congênita rara que corresponde a um distúrbio de neurodesenvolvimento, neurodegenerativo, caracterizado por atraso no desenvolvimento psicomotor e início infantil ou infanto-juvenil de movimentos involuntários hiperkinéticos, incluindo coreia e atetose. Os movimentos anormais podem ser graves, às vezes resultando em incapacidade de sentar, andar, falar ou comer. Os movimentos hiperkinéticos podem ser exacerbados por gatilhos específicos, como estresse, doença ou alta temperatura. Alguns pacientes têm anormalidades cerebrais, como atrofia cerebral ou corpo caloso fino, e alguns pacientes podem desenvolver convulsões.

O Requerente internou em 12/01/2024 por conta da piora importante dos movimentos extrapiramidais, evoluindo com múltiplas complicações, inclusive pneumonia aspirativa, e foram realizadas gastrostomia e traqueostomia na internação, sendo a melhor resposta obtida com adição do **canabidiol** ao arsenal terapêutico. A doença descrita é uma doença crônica degenerativa progressiva e apresentou melhora substancial com uso de **canabidiol**, além de redução da dose de outros fármacos. Por isso, é indicado a manutenção do tratamento pela boa resposta clínica. Consta solicitação de uso de **Canabidiol 100mg/mL (Prati-Donaduzzi®)** – 0,5ml de 12/12 horas – para controle dos movimentos. Atualmente, está em uso de: Clobazam, Haloperidol, **Canabidiol**, Risperidona, Triexifenidil (Artane®)(Evento 16, ANEXO2, Página 1).

Acostado aos autos (Evento 3, DESPADEC1, Página 7) encontra-se o **PARECER TÉCNICO/SES/SJ/NATJUS-FEDERAL Nº 1873/2024**, emitido em 30 de outubro de 2024, referente ao Processo: 5074426-83.2024.4.02.5101 (33ª Vara Federal do Rio de Janeiro) no qual foi no qual foi esclarecido os aspectos relativos ao quadro clínico do Autor, à indicação e à disponibilização, no âmbito do SUS, do fornecimento do produto **Canabidiol 100mg/mL (Prati-Donaduzzi®)**.

Cabe ressaltar que este Núcleo mencionou o uso do **canabidiol** no contexto de **epilepsia** com base em documento médico acostado ao processo nº 5074426-83.2024.4.02.5101 (Evento 1, ANEXO2, Página 22), que indicava a presença de epilepsia no quadro clínico do Autor. Contudo, o novo documento médico esclarece que o **canabidiol** foi prescrito especificamente para o tratamento da doença genética congênita rara **NEDIM (Neurodevelopmental Disorder With Involuntary Movements)**.

Dessa forma, em atendimento à solicitação, este Núcleo limitará sua análise ao uso do **canabidiol** exclusivamente no contexto do tratamento da doença genética congênita rara **NEDIM (Neurodevelopmental Disorder With Involuntary Movements)**.

Dados de revisão sistemática apontam para um papel protetor do **canabidiol (CBD)** no tratamento e/ou prevenção de alguns distúrbios do movimento. Embora os estudos sejam escassos, o CBD parece ser eficaz no tratamento de movimentos distônicos, tanto primários quanto secundários. Investigações futuras são necessárias para endossar esses dados iniciais e elucidar os mecanismos envolvidos no potencial preventivo e/ou terapêutico do CBD em distúrbios do movimento¹.

Considerando todo o exposto acima, **conclui-se que são escassas as evidências científicas que apoiam o uso de produtos derivados de Cannabis para o manejo do quadro clínico do Autor** – doença genética congênita rara **NEDIM (Neurodevelopmental Disorder With Involuntary Movements)**.

O produto **canabidiol não foi avaliado** pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC)² para **NEDIM (Neurodevelopmental Disorder With Involuntary Movements)**.

No que tange à disponibilização, no âmbito do SUS, cabe informar que o **canabidiol 100mg/mL (Prati-Donaduzzi®)** **não integra** nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) dispensados no Município e do Estado do Rio de Janeiro. Logo, não cabe o fornecimento em nenhuma esfera do SUS.

No que se refere à existência de alternativas terapêuticas ofertadas pelo SUS, evidencia-se que **não há** Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) d **NEDIM**, publicado pelo Ministério da Saúde e, consequentemente, medicamentos ofertados pelo SUS para tratamento da citada doença.

Acrescenta-se que o **NEDIM** é considerado uma doença rara. Assim, cumpre salientar que o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, aprovando as Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do SUS e instituiu incentivos financeiros de custeio. Ficou estabelecido que a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras³ tem como objetivo reduzir a mortalidade, contribuir para a redução da morbimortalidade e das manifestações secundárias e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno, redução de incapacidade e cuidados paliativos.

Ainda de acordo com a referida Política, o Ministério da Saúde ficou responsável por estabelecer, através de PCDT, recomendações de cuidado para tratamento de doenças raras, levando em consideração a incorporação de tecnologias pela CONITEC, de maneira a qualificar o cuidado das pessoas com doenças raras⁴. Contudo, reitera-se que **não há** Protocolo Clínico e

Diretrizes Terapêuticas (PCDT)⁵ publicado para o manejo da NEDIM (Neurodevelopmental Disorder With Involuntary Movements).

Insta mencionar que especificamente o produto **canabidiol 100mg/mL** (Prati-Donaduzzi®) **possui registro** na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Tal produto encontra-se registrado como **produto de cannabis e não como medicamento**.

Conforme a RDC N° 327, de 9 de dezembro de 2019, o **Canabidiol** poderá ser prescrito quando estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no mercado brasileiro. **A indicação e a forma de uso dos produtos à base de Cannabis são de responsabilidade do médico assistente⁵.**

No que concerne ao valor do produto pleiteado, no Brasil para um medicamento ser comercializado no país é preciso obter o registro sanitário na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e a autorização de preço máximo pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)⁶.

Considerando que o produto pleiteado **não corresponde à medicamento registrado na ANVISA**, deste modo, **não tem preço estabelecido pela CMED⁷.**

É o parecer.

O parecer concluiu ***"que são escassas as evidências científicas que apoiam o uso de produtos derivados de Cannabis para o manejo do quadro clínico do Autor – doença genética congênita rara NEDIM (Neurodevelopmental Disorder With Involuntary Movements).***

O produto canabidiol não foi avaliado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC)² para NEDIM (Neurodevelopmental Disorder With Involuntary Movements).

No que tange à disponibilização, no âmbito do SUS, cabe informar que o canabidiol 100mg/mL (Prati-Donaduzzi®) não integra nenhuma lista oficial de medicamentos (Componentes Básico, Estratégico e Especializado) dispensados no Município e do Estado do Rio de Janeiro. Logo, não cabe o fornecimento em nenhuma esfera do SUS."

Essa Turma Recursal, em processos análogos, firmou o entendimento que diante de evidências científicas insuficientes resta caracterizada a impossibilidade do Estado em fornecer medicamentos ou produtos experimentais.

SAUDE. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 200 MG/ML. TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS INSUFICIENTES. MANIFESTAÇÃO DO NAT E DA FIOCRUZ PELA NECESSIDADE DE ESTUDOS. IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO FORNECER MEDICAMENTO OU PRODUTOS EXPERIMENTAIS. TEMA 500 DO STF. (Sessão do 23/05/2023, Sessão Virtual, Processo 31 da Pauta, Processo nº 5004147-56.2021.4.02.5108. Rel. Dra. Daniella Motta)

Assim está ausente a probabilidade do direito pleiteado.

Por tais razões, **VOTO** por **CONHECER** e **DAR PROVIMENTO** ao recurso da União. Publique-se. Intimadas as partes, certifique-se o trânsito em julgado.

5091722-21.2024.4.02.5101

510015141864 .V10